



البرنامج العلمي الشامل : الطب التكاملّي والعلوم الطّبيعيّة: مقارنة تكاملية بين العلم والطاقة والصحة النفسية وفق رؤية حديثة

برعاية اتحاد الجامعات الدولي والمنظمة الدولية للطب التكميلي والعلوم الطبيعية

إعداد وتقديم

د/ ياسر قطب

دكتورة إدارة الأعمال وماجستير علم النفس والسلوك الإنساني

وبكالوريوس في العلوم تخصص نبات وكيمياء

مستشار علمي وتطوير لشركات الأدوية - محاضر وباحث في العلوم البيئية

عضو اتحاد الجامعات الدولي والعديد من الهيئات الدولية

عضو اللجنة الإستشارية بمجلة اتحاد الجامعات الدولي

المحاضرة الثالثة

من النظرية إلى الممارسة: تفعيل الطب التكاملي في السياق العلاجي والوقائي

مقاربة علمية تطبيقية لبناء نموذج علاجي متكامل قائم
على الدليل،
يحترم تعددية المصادر ويخدم صحة الإنسان الشاملة.

ملخص المحاضرة الثانية: الطب التكاملية والتمييز بين المفاهيم

في هذه المحاضرة قمنا بـ

□ توضيح الفرق بين:

✓ الطب الأكاديمي

✓ الطب التقليدي

✓ العلاج التكميلي

✓ الطب التكاملية

□ بيان أن مصطلح الطب التكاملية Integrative Medicine

هو الأكثر دقة علميًا ومؤسسيًا، بناءً على تبنيه من

□ Harvard Osher Center

□ Mayo Clinic

□ NCCIH

❑ التمييز بين الدواء النباتي والدواء المُلَخَّص والدواء الخليط

• الحالات التي يمكن فيها استخدام العلاج الطبيعي منفردًا،
والحالات التي تتطلب الدمج مع العلاج الأكاديمي

- ❑ مناقشة قضية المصطلح "الدواء الكيميائي"،
وتقسيمه إلى مستخلص طبيعي - "دواء مُخلَق أو مصنع".
- ❑ تقديم مقارنة علمية بين الطب التكاملي والعلاج الشمولي، وتوضيح الخطأ الشائع في مفهوم الطب الشمولي Holistic Medicine

❑ تسليط الضوء على غياب الطب الإسلامي عن

: رسالة هذه المحاضرة

بعد أن أصلنا المفاهيم بدقة، وأوضحنا موقفنا العلمي من "مصطلح الطب التكاملي وتمييزه عن غيره من الاتجاهات، نطلق اليوم إلى محور بالغ الأهمية: كيف نُفَعِّل هذا التكامل علميًا وعمليًا؟ كيف يُترجم الطب التكاملي إلى ممارسات طبية حقيقية تخدم الإنسان؟ وكيف نبني إطارًا مؤسسيًا وأخلاقيًا للتعامل مع تعدد المدارس العلاجية؟

هذه المحاضرة تهدف لإطلاق النموذج العملي
لرؤية العلم إذا لم يُترجم إلى أثر، بقي حبيس
الأكاديمية

أهداف المحاضرة الثالثة:

□ استكمال بناء النموذج العلاجي التكاملي، من خلال:

1. توضيح المبادئ التي يقوم عليها هذا النموذج
2. عرض خطوات تصميم خطة علاج متكاملة
3. التمهيد للأمثلة التطبيقية الواقعية التي سناقشها لاحقًا

□ في المحاضرتين السابقتين، أسسنا المفاهيم، وناقشنا التحديات، واقتربنا من رؤية الطب التكاملي لا كبديل، بل كمقاربة **تُعترف بكل ما يُفيد الإنسان** إذا ثبت نفعه وأدير بعلم ومسؤولية.

أما اليوم، فنخطو خطوة جديدة نحو **تطبيق هذه الرؤية ضمن نموذج عملي علمي وأخلاقي**، يُظهر أن الطب التكاملي ليس "فكرة بديلة"، بل "نظام متكامل للعلاج والحياة".

❓ الطب التكاملي وفق رؤيتي ومراجعاتي كباحث

الطب التكاملي ليس مجرد استخدام بعض العلاجات الطبيعية إلى جانب الطب الأكاديمي أو كبديل عنه، بل هو رؤية علاجية شمولية تستند إلى التوازن بين الجسد والعقل والروح، وتمزج بين الحكمة التقليدية والتقدم العلمي الحديث. إنه منهج علاجي قائم على الأدلة، يُعزّز الشفاء الطبيعي ويُصمم لكل مريض حسب احتياجاته، جامعًا بين الممارسات التقليدية والحديثة في إطار علمي وأخلاقي مدروس.

"حين نعالج الإنسان دون أن نُبصر أله النفساني، أو
نُدّاء حاجته الروحية، نُعالجه نصف علاج الطبيب"

المحور الأول: أسس تفعيل الطب التكاملي في النظام الصحي

لا يمكن تفعيل الفهم الفلسفي في شكل تطبيق في أي بيئة علمية إلا إذا أُدركت الفكرة الجوهرية بين:
• الرؤية الفلسفية التي ينطلق منها الطب التكاملي.
• والتطبيق الإكلينيكي الذي يحتاج إلى أدوات علمية وتقنية محددة.

الفرق بين الفهم الفلسفي والتطبيق الإكلينيكي

المقارنة	الفهم الفلسفي للطب التكاملي	التطبيق الإكلينيكي للطب التكاملي
الرؤية	الإنسان ككل: جسد، عقل، نفس، روح	الحالة المرضية بتفاصيلها السريرية
المنهج	التوازن، الانسجام مع الطبيعة، المعالجة الشاملة	بروتوكولات علاجية دقيقة، وجرعات، ومؤشرات سريرية
اللغة	مصطلحات إنسانية	مصطلحات علمية - بيولوجية

المقارن ة	الفهم الفلسفي للطب التكاملي	التطبيق الإكلينيكي للطب التكاملي
أدوات التقييم	الشعور بالتحسن، جودة الحياة، التوازن الداخلي	تحاليل مخبرية، مؤشرات حيوية، نتائج سريرية مثبتة
الدافع	تعزيز الشفاء الذاتي لدى المريض	تقديم تدخل علاجي مباشر وفعّال
المحور الأساسي	دعم الإنسان من الداخل ليقاوم المرض	مكافحة المرض مباشرة
القبليّ، التفصيليّ، العلميّ لهذا الفرق	رقمي - علمي - إحصائي	

**[?] الفهم الفلسفي للطب التكاملي هو ما يُعطي هذا التوجه بعده
الإنساني والأخلاقي، ويجعله يُراعي التجربة النفسية والروحية للمريض.**

**[?] أما التطبيق الإكلينيكي فهو ما يمنحه الاعتراف الطبي
والتشريعي، لأنه يُحوّل هذه الفلسفة إلى أدوات قابلة للقياس والتقييم.**

□ **القلق المزمن:**

• □ **الفهم الفلسفي:**

يُنظر إلى القلق كنتيجة لاضطراب في التوازن الداخلي (طاقى، نفسى، نمط حياة).

يُعالج بالتأمل، الحمامة، الأعشاب، جلسات استرخاء.

• □ **التطبيق الإكلينيكي:**

يُستخدم مقياس GAD-7 لتقييم القلق، وتُحدّد الخطة بناءً على الأدلة :
CBT - تمارين التنفس - دعم غذائى

مدروس.

□ **المرجع:**

Lake, J. (2009). Textbook of Integrative Mental Health Care.
.American Psychiatric Publishing

وُتحدّد الخطة بناءً على الأدلة:

CBT - تمارين التنفس - دعم غذائي مدروس.

GAD-7 (Generalized Anxiety Disorder - 7):

هو مقياس علمي مُعتمد دوليًا يستخدم لتقييم حدة اضطراب القلق العام عند الأفراد، وهو مكون من 7 أسئلة تُقيّم مدى تكرار الأعراض خلال الأسبوعين السابقين.

• يُستخدم في العيادات النفسية وطب الأسرة.

• الدرجة الإجمالية تُساعد على تحديد ما إذا كان القلق:

خفيفًا 5-9 ، متوسطًا 10-14 ، شديدًا 15-21

✓ استخدام في الطب التكاملي: يسمح بقياس موضوعي لفعالية

العلاجات التكميلية مثل:

• التأمل

• التمارين التنفسية (Breathwork)

• الأعشاب

العلاج الموصى به بناءً على الدليل العلمي

:Evidence-Based Interventions

1. العلاج المعرفي السلوكي CBT :

من أكثر العلاجات النفسية فعالية لاضطراب القلق.

2. تمارين التنفس العميق Deep Breathing :

تقلل من تنشيط الجهاز العصبي السمبثاوي وتساعد على الاسترخاء.

3. الدعم الغذائي المدروس:

1.المغنيسيوم: يدعم الجهاز العصبي.

2.فيتامين B6: مرتبط بتحسين المزاج.

3.أوميغا-3: تخفف الالتهاب وتحسّن التوازن الكيميائي العصبي.

Spitzer RL, Kroenke K, Williams JB, Löwe B.

A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7.

Arch Intern Med. 2006;166(10):1092-1097.

ثالثًا: لماذا نحتاج إلى الجمع بين الاثنين؟

الفلسفة تُعطي المعنى، والعلم يُعطي الدليل، والطب التكاملي الحقيقي لا يقوم إلا على الاثنين معًا

✓ التطبيق بدون رؤية = تدخل ميكانيكي فاقد للروح

✓ **"الرؤية بدون تطبيق ليس خطًا بل انحرافًا"**
المريض، بل أن تفهمه.

— بقلم د. ياسر قطب

وبعد معرفتنا للفرق بين الفهم الفلسفي للطب التكاملي والتطبيق الإكلينيكي من هنا نستطيع أن ننطلق على المحور الفرعي الثاني من المحور الأول :

وهو لماذا لم يُفَعَّل الطب التكاملي رسميًا

في معظم الأنظمة الصحية؟

❑ لماذا لم يُفعَّل الطب التكاملّي رسميًا في معظم الأنظمة الصحية؟

❑ الهدف :

تحليل الأسباب التي جعلت الطب التكاملّي لا يُعتمد بشكل رسمي في النظم الصحية العالمية رغم الاعتراف المتزايد بأهميته، مع تقديم توثيق وتحليل نقدي دون تصادم.

✓ فبالرغم من ازدياد الاهتمام العالمي بالطب التكاملّي، إلا أن كثيرًا من الأنظمة الصحية التقليدية لم تُفعَّل هذا النموذج ضمن سياقاتها الرسمية، مما يطرح سؤالًا

السبب	التفسير العلمي
غياب إطار تشريعي وتنظيمي موحد	لا يوجد تعريف مؤسسي عالمي يُحدّد ما الذي يُعترف به كعلاج تكاملي وما لا يُعترف به، خصوصًا أن بعض الأنظمة تُدرج الطب الصيني، وآخرون لا يعترفون بالحجامة أو الطاقة.
نقص التمويل البحثي للعلاجات الطبيعية	معظم الأبحاث الممولة تأتي من شركات الأدوية الكبرى، مما يحدّ من تمويل الدراسات حول الأعشاب أو التغذية العلاجية أو التأمل.
صعوبة قياس بعض	مثل العلاج بالطاقة أو التأمل العميق،

السبب	التفسير العلمي
الخوف من 4. الشعوذة والممارسات غير المنظمة	بعض الممارسين يخلط بين الطب التكاملي والممارسات الشعبية غير المنضبطة، مما يخلق قلقًا عند الجهات التنظيمية.
غياب الكفاءات 5. الطبية المؤهلة علميًا	كثير من مقدمي العلاج التكاملي لا يملكون تدريبًا أكاديميًا، مما يضعف الثقة المؤسسية في هذا المسار.
الهيمنة المعرفية 6. للطب الغربي الأكاديمي	تستند المنظومات الصحية الحديثة إلى النموذج البيولوجي النفسي، مما يجعل الاعتراف بعلاجات غير تقليدية أكثر صعوبة.

ثالثًا: شواهد من الواقع بالرغم من الاعتراف الرسمي من

Mayo Clinic، وHarvard Osher Center وNCCIH،

إلا أن هذه المراكز لا تُدير أنظمة صحية، بل تُقدم خدمات موازية.

□ المرجع:

Frenkel M, Borkan J. An approach to integrating

complementary-alternative medicine into primary care. Family Practice. 2003; 20(3): 324-332.

رابعًا: الرؤية التحليلية "الطب التكاملي" لا يُقصى من الأنظمة الصحية بسبب ضعفه، بل لأن المنظومة التقليدية لم تُصمم لاستيعابه، وما نحتاجه اليوم ليس فقط تطوير العلاجات، بل تطوير السياسات والبُنى القيمية التي تحتضن هذا التكامل.

□ **معايير إدماج الطب التكاملي في النظام الصحي**
لا يكفي أن تكون العلاجات فعالة أو تقليدية أو مرغوبة جماهيريًا لكي
تُدمج في النظام الصحي؛ بل يجب أن تمر عبر معايير علمية
ومؤسسية وأخلاقية واضحة، تجعل إدماجها ممكنًا ومشروعًا وقابلًا
للتطبيق.

✓ الأمان (Safety)
0 **المعايير الأساسية لإدماج أي تدخل علاجي**
✓ الفعالية (Effectiveness)
تكاملي ✓ قابلية التقييم (Measurability)

✓ التوافق مع قيم الرعاية الصحية (Ethics & Patient Rights)
✓ إمكانية الدمج (Integrability)

■ **مرجع المعايير:**

NCCIH Research Framework – National Center for Complementary and Integrative Health (NIH)

<https://www.nccih.nih.gov/research>

المعيار	التوضيح العلمي
الأمان (Safety)	يجب إثبات خلو العلاج من الأضرار الجانبية الجسيمة، خاصة عند الاستخدام طويل الأمد أو عند التفاعل مع أدوية أخرى.
الفعالية (Effectiveness)	يجب أن يكون هناك دليل علمي مثبت (أبحاث - تجارب سريرية - مراجعات منهجية) يثبت فعاليته في علاج مرض معين.
قابلية التقييم (Measurability)	يمكن قياس نتائج العلاج باستخدام مؤشرات صحية موضوعية (تحاليل - قياسات - مقاييس تقييم نفسي أو بدني).
التوافق مع قيم الرعاية	لا يخالف أخلاقيات الطب أو حقوق

ثالثًا: أمثلة تطبيقية واقعية لعلاجات تكاملية تم اعتمادها

العلاج التكاملي	معيار تم تحقيقه	النظام الصحي المعترف به
الوخز بالإبر Acupuncture	الفعالية + الأمان	بريطانيا - NHS / Mayo Clinic
التأمل الواعي (Mindfulness)	قابلية القياس + الأخلاقية	أمريكا - NCCIH
المكملات النباتية (Prostan)	فعالية نسبية + تقييم واضح	ألمانيا - هيئة تنظيم الأدوية العشبية
العلاج اليدوي تقويم العمود الفقري والعظام	فعالية في حالات محددة	كندا / الولايات المتحدة

توضيح الأمثلة في جدول "العلاجات التكميلية المعترف بها" □ الوخز بالإبر Acupuncture

تقنية صينية تقليدية تعتمد على إدخال إبر رفيعة جدًا في نقاط معينة بالجسم لتحفيز مسارات الطاقة Qi وتحسين التوازن الحيوي.

□ المعايير التي تم تحقيقها:

الفعالية: ثبت علميًا عبر العديد من الدراسات فعاليتها في حالات مثل آلام الظهر، الصداع النصفي، والتوتر العضلي.
الأمان: حين يُمارس من قبل مختصين مدربين، يُعتبر آمنًا جدًا وبآثار جانبية طفيفة.

□ النظام الصحي المعترف به:

الخدمة الصحية البريطانية NHS : يُعترف به لعلاج بعض أنواع الألم

❓ التأمل الواعي Mindfulness Meditation

تقنية تعتمد على وعي الفرد الكامل بلحظته الحالية دون إصدار أحكام، وتُستخدم في ضبط التوتر، الأرق، والاكتئاب.

❑ **المعايير التي تم تحقيقها:**

• **قابلية القياس:** يمكن قياس تأثيره على القلق والاكتئاب من خلال أدوات مثل: GAD-7 و PHQ-9

• **الأخلاقية:** لا يحمل أي ضرر أو تضارب مع خصوصية أو قناعة المريض، ويسمح له بمساحة ذاتية للتأمل.

❑ **النظام الصحي المعترف به:**

• المركز الوطني الأمريكي للصحة التكميلية والتكاملية NCCIH:
أدرجه ضمن البرامج الوقائية والعلاجية للقلق والتوتر والألم المزمن.

PHQ-9؟

PHQ-9 هو اختصار لـ: Patient Health Questionnaire – 9 items

وهو أداة تقييم سريري قصيرة مكوّنة من 9 أسئلة، تُستخدم لقياس درجة الاكتئاب عند البالغين

مميزات القياس :	التوضيح
عدد الأسئلة	بنود رئيسية تعكس أعراض الاكتئاب كما في 9 DSM-5
مقياس الإجابة	من 0 (أبدًا) إلى 3 (تقريبًا كل يوم)
النطاق الكلي للدرجات	من 0 إلى 27
مدة التقييم	يغطي الأسبوعين الأخيرين قبل الإجابة
الوقت اللازم	دقائق فقط 2-3
الاستخدام	تشخيص الاكتئاب، تقييم شدته، متابعة الاستجابة

تفسير الدرجات:

درجة الاكتئاب	مجموع النقاط
طبيعي / لا اكتئاب	0 - 4
اكتئاب خفيف	5 - 9
اكتئاب متوسط	10 - 14
اكتئاب شديد الدرجة 10-19 الدرجة 10-19	15 - 19

اكتئاب شديد
الدرجة 10-19
الدرجة 10-19

لماذا يُستخدم في الطب التكاملي؟

• يُستخدم PHQ-9 في مراكز الطب التكاملي كأداة تقييم أولي وقياس استجابة المرضى للعلاج النفسي، التأمل، المكملات الغذائية، أو العلاج السلوكي.

• يسمح للطبيب بتوثيق تطور الحالة خلال العلاج النفسي غير الدوائي أو العلاجات التكاملية.

Kroenke, K., Spitzer, R.L., & Williams, J.B. (2001). The PHQ-9: Validity of a brief depression severity measure. Journal of General Internal Medicine, 16(9), 606-613.

المحور الثاني : بناء النموذج العملي للطب التكاملي :من الفكرة إلى التطبيق

بعدما ناقشنا أسس إدماج الطب التكاملي في النظام الصحي،
أن الألوان للانتقال من التأصيل النظري إلى بناء نموذج عملي
يوضح كيف يمكن للطبيب أو المؤسسة الصحية أن تطبق الرؤية
التكاملية بأسلوب علمي ومنهجي.

□ **المبادئ التي يقوم عليها النموذج العلاجي التكاملي**
تحديد المراكز التي تجعل أي نموذج علاجي تكاملي ناجحًا، علميًا
وإنسانيًا وأخلاقيًا.

المبادئ الجوهرية التي يُبنى عليها النموذج العلاجي التكاملي:

مركزية المريض (Patient-Centeredness) يُصمَّم العلاج بحسب خصائص كل مريض وظروفه وليس وفق وصفة عامة ثابتة.

الشمول (Holism) يُراعي الحالة الجسدية، النفسية، الروحية، والاجتماعية للمريض.

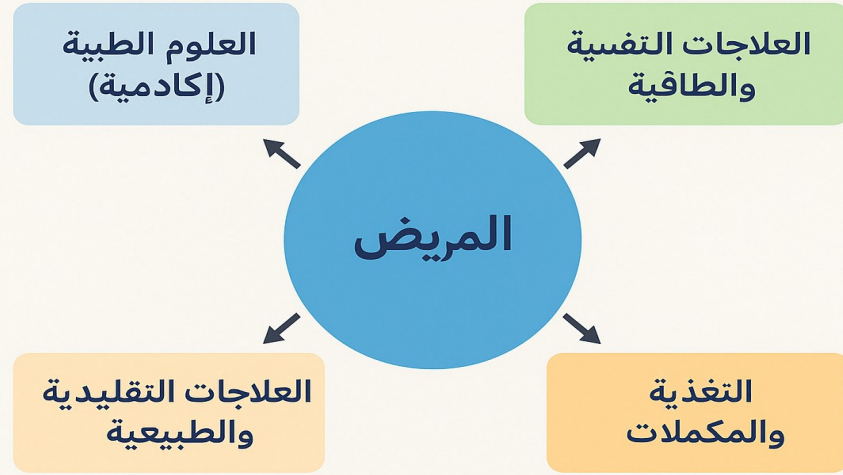
التكامل (Integration) يجمع بين العلاجات التقليدية والأكاديمية والبدنية والطبيعية والعقلية ضمن خطة واحدة.

الأدلة العلمية (Evidence-Informed Practice) لا يُستخدم العلاج إلا إذا كانت له قاعدة معرفية أو تجربة سريرية داعمة، حتى وإن لم تكن تجربة تقليدية Randomized Trials .

العلاقة العلاجية (Therapeutic Relationship) يُبنى على الثقة والتواصل والتفاهم بين المعالج والمريض، وليس على السلطة الطبية فقط.

التمكين الذاتي (Empowerment) يُشجِّع المريض على المشاركة الواعية في علاجه، ويدرب على التغيير السلوكي والدعم الذاتي.

توضيح العلاقة بين مبادئ النموذج العلاجي :
حين نربط بين الشمول + الأدلة + التمكين + التكامل، نكون قد أسسنا علاجاً يُراعي الإنسان ككل، ويوفّر خطة مخصصة له، ويُبقّيه مشاركاً، ويستخدم ما ثبت نفعه.



القيم الأخلاقية • الأدلة العلمية الحوار العلاجي

العلاقة بين المريض والطبيب
"المريض" هو المركز وتدور حوله أركان النموذج العلاجي :

- ☐ العلوم الطبية (أكاديمية)
- ☐ العلاجات النفسية والطاقة
- ☐ التغذية والمكملات
- ☐ العلاجات التقليدية والطبيعية

[?] وكلها موجهة من قبل: القيم الأخلاقية + الأدلة العلمية + الحوار العلاجي

خطوات تصميم خطة علاج تكاملية (دوائي -
نفلاطي التكاملية) يقدم وصفه (علاجية جاهزة، بل يُصمّم خطة
علاجية شخصية تتوافق مع احتياجات المريض الجسدية
والنفسية والروحية ويحترم خصوصية الإنسان ويفعل
بطريقة تحافظ على كرامته ، وتعيد إليه توازنه من
الداخل .

نحن لا نبحث فقط عن تخفيف الأعراض، بل عن
تعزيز قدرة الجسد على الشفاء الذاتي
دعم الجهاز النفسي والعصبي بطرق آمنة ومتكاملة
بناء علاقة علاجية تقوم على المشاركة لا التلقين
إن نجاح الخطة العلاجية يبدأ من الوعي بمنهج الطب التكاملية
كفلسفة علاج، وليس مجرد تقنية.

ثانيًا: الخطوات الأساسية لبناء خطة علاج تكاملية فعّالة

الخطوة	الشرح
التقييم الشامل لحالة المريض	يُشمل فيه التقييم الجسدي (تحاليل، فحوصات)، التقييم النفسي اختبارات مثل PHQ-9 و GAD-7)، ونمط الحياة.
تحديد الأهداف العلاجية الفردية	هل الهدف تخفيف الألم؟ تحسين النوم؟ دعم الحالة النفسية؟ تقليل الأدوية؟
اختيار أدوات العلاج من الأنظمة المتكاملة	مزيج من العلاجات الدوائية، النفسية، الغذائية، والروحية - وفق الأدلة وحالة المريض.
تصميم الجدول الزمني والمتابعة	يُحدد توقيت بدء كل مكوّن، ومدة العلاج، وتكرار التقييم.
تمكين المريض وثيقفه	شرح خطة العلاج له بوضوح، وتدريبه على تقنيات التنفس، الغذاء، أو التأمل الذاتي.
التقييم المستمر والتعديل	اجتماعي دوري لتقييم التقدم وتعديل الخطة حسب الحاجة.

ثالثًا: مثال تطبيقي لحالة "قلق مزمن"

□_التقييم:

• مريض يعاني من قلق متوسط $GAD-7 = 13$ ، نوم متقطع،
وتوتر مزمن في العضلات.
[?] خطة العلاج:

المجال	التدخل
دوائي	جرعة خفيفة من SSRI حسب تقييم الطبيب النفسي.
نفسي	جلسات CBT أسبوعية + تدريبات Mindfulness.
طبيعي	مكملات المغنيسيوم + مشروب مهدئ ليلي (نعناع، بابونج).
روحي / المتطوعي [?]	تدريبات تأمل وتنفس عميق صباحي + جلسة أسبوعية استرخاء صوتي.

• تقييم $GAD-7$ بعد 4 أسابيع + مقياس جودة النوم.

رابعًا: أهم الشروط لضمان نجاح الخطة

- يجب أن تكون مرنة وقابلة للتعديل
- تقوم على التواصل المستمر مع المريض
- لا تُقصي أي فرع علاجي علمي قد يُفيد المريض

أوضحنا اليوم كيف يُبنى نموذج الطب التكاملي على أساس معرفي وأخلاقي وإنساني.
تناولنا خطوات تصميم خطة علاجية تكاملية تجمع بين الدواء والعلاج النفسي والطبيعي والروحي.

في الطب التكاملي، لا يوجد علاج يُفرض، بل خطة تُصمَّم لكل مريض رحلته، ولكل رحلة خارطة متكاملة
د. ياسر قطب —

طبيب القلب في المستشفى القادسية

